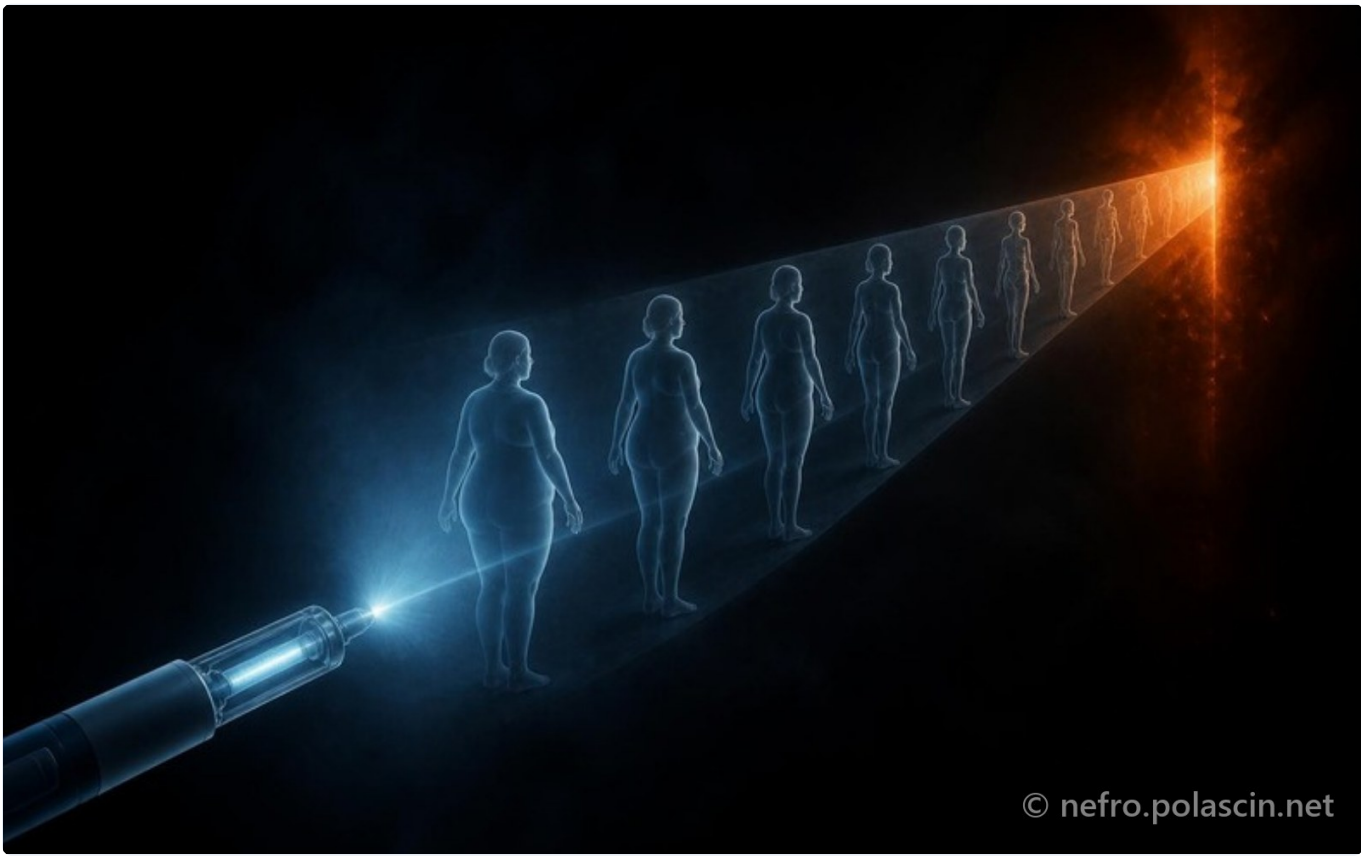
GLP-1 a poruchy príjmu potravy: rastúce obavy z nevhodného používania a ako im predchádzať

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026



Ilustračná scéna. Ten istý účinok, ktorý pomáha, sa u rizikového pacienta môže stať nástrojom poruchy príjmu potravy.

V posledných rokoch sa prístup k agonistom GLP-1 receptorov výrazne zjednodušil. Perorálne prípravky a rýchly prístup cez telemedicínske siete zvyšujú pravdepodobnosť, že o tieto lieky požiadajú aj ľudia mimo okruhu pacientov, pre ktorých sú určené. Medzi odborníkmi sa opakovane objavujú obavy, že časť žiadostí o GLP-1 môže súvisieť s nedostatočným zhodnotením porúch príjmu potravy alebo so skrytou anamnézou, ktorá sa pri „rýchlych“ predpisoch neodhalí.

Nasledujúci prehľad zhŕňa, na čo upozorňujú klinici, a ponúka praktický rámec, ako k indikácii GLP-1 pristupovať obozretne.

Prečo sa o tom diskutuje

Agonisty GLP-1 receptorov sú schválené pre pacientov s diabetom mellitus 2. typu a pre vybrané kategórie pacientov s obezitou alebo nadváhou so sprievodnými komorbiditami. Pribúdajú však predpisy pre ľudí, ktorí tieto typické indikácie nespĺňajú. Podľa analýzy trendov v retailových lekárňach sa podiel takýchto predpisov zvýšil zo 4,5 % v roku 2018 na 17 % v roku 2023.

Obavy nie sú iba teoretické. Odborníci zdôrazňujú najmä tri okruhy problémov:

1. **Dopyt „kvôli vzhľadu“ alebo „ešte trochu“**, hoci pacient už má hmotnosť v pásme, kde ďalšie znižovanie neprináša medicínsky prínos.
2. **Nedostatočná identifikácia porúch príjmu potravy** alebo ich rizikových vzorcov, ktoré môžu byť pre pacienta citlivé a v anamnéze, ktorú sám uvádza, nemusia zaznieť.
3. **Riziko škôd pri nevhodne stanovenom cieli chudnutia** – napríklad nadmerná redukcia hmotnosti či strata svalovej hmoty; v citovanej literatúre sa spomína aj pankreatitída.

Kde hľadať varovné signály v anamnéze

V praxi sa ukazuje, že pri posudzovaní vhodnosti GLP-1 nestačí hodnotiť len index telesnej hmotnosti (BMI) a „cieľovú hmotnosť“. Kľúčové je cielene sa pýtať na vzorce správania okolo jedla a na vnímanie vlastného tela.

Ako varovné signály sa opakovane uvádzajú napríklad:

- túžba schudnúť aj po **dosiahnutí zdravej cieľovej hmotnosti** („len ešte kúsok“),
- snaha dosiahnuť **výlučne estetický cieľ**,
- nepriznaná alebo skrytá anamnéza poruchy príjmu potravy, prípadne **neochota hovoriť o minulých epizódach**,
- epizódy **prejedania sa, purgatívneho správania (vracanie, preháňadlá) alebo reštrikcie** a rigidné „pravidlá“ okolo jedla,
- výrazný strach z priberania a pretrvávajúce mentálne zaujatie jedlom (v anglickej literatúre označované ako „food noise“),
- požiadavka na **rýchlu redukciu** bez zjavnej medicínskej potreby.

Niektorí klinici považujú za praktické viesť rozhovor tak, aby sa ťažisko prenieslo z kozmetického cieľa na otázku metabolického zdravia a celkovej prevencie. Skúsenosť naznačuje, že takýto posun cieľa dokáže u časti pacientov znížiť tlak na to, aby „len schudli“.

Skríning: čo má zmysel a ako ho robiť

Viacerí lekári pred predpísaním GLP-1 vyžadujú vyšetrenie porúch príjmu potravy alebo aspoň posúdenie ich rizika.

1. Systematická anamnéza pri každom začiatku liečby

Podľa jedného z opísaných prístupov lekár zisťuje napríklad to, či pacient zažíval **stratu kontroly pri jedení** a či mal v minulosti **poruchu príjmu potravy**. Pri pozitívnej odpovedi sa dopĺňa validovaný skríning.

2. Využitie skríningových nástrojov (napríklad BEDS-7)

Z konkrétnych nástrojov sa uvádza dotazník **Binge Eating Disorder Screener-7 (BEDS-7)**; ďalšie nástroje sú dostupné prostredníctvom organizácie National Eating Disorders Association.

Hoci sa časť lekárov opiera o formálne nástroje, veľký význam má aj obyčajný klinický rozhovor – podrobná anamnéza celoživotných vzorcov správania a obáv týkajúcich sa vnímania vlastného tela.

3. Rozhovor o nutričnej realite pri potlačení chuti do jedla

Ak sa liečba GLP-1 už začne, treba počítať s praktickým problémom: potlačenie chuti do jedla môže pacientovi s rizikovým správaním sťažiť príjem **dostatočného množstva bielkovín**, a tým prispieť k strate svalovej hmoty. Preto sa odporúča aktívna nutričná edukácia a podľa kontextu pacienta aj zapojenie psychológa či dietológa.

Kedy byť obzvlášť opatrný

Nevhodné používanie sa podľa skúseností lekárov objavuje častejšie v niektorých skupinách. Z klinickej praxe vyplýva najmä:

- **ženy v strednom veku**, ktoré už schudli a chcú znížiť hmotnosť ešte o „posledných pár kilogramov“,
- pacienti s **už preukázanou anamnézou poruchy príjmu potravy** alebo s výraznými prejavmi rizikového správania,
- situácie, v ktorých sa u pacienta už prejavuje **strata svalovej hmoty**, klesajúca kostná denzita alebo komplikácie.

Ilustruje to konkrétny príklad: pacientka s anamnézou poruchy príjmu potravy GLP-1 nedostala, ale dostala odporúčanie viesť potravinový denník. Spoločná revízia denníka umožnila riešiť kvalitu výživy a vysvetliť, prečo môže pri potlačení chuti do jedla vzniknúť problém so zachovaním svalovej hmoty.

Nejednoznačnosť dôkazov a rozdiel medzi indikáciou a zneužitím

Dôkazy tu nie sú jednoznačné. Niektoré štúdie môžu naznačovať potenciálny prínos semaglutidu pri psychogénnom prejedaní (binge eating disorder). Klinická skúsenosť časti autorov však vedie k opatrnosti a k interpretácii, že problémom nemusí byť samotný mechanizmus účinku lieku, ale spôsob, akým sa liečba používa – u koho sa indikuje a aký cieľ sleduje.

Jedna z opísaných skúseností zdôrazňuje, že pri nevhodnom nastavení liečby alebo u pacientov, ktorí v skutočnosti primárne zápasia s psychiatrickým ochorením, môže dôjsť k nadmernej redukcii hmotnosti a k pokračovaniu liečby dlhšie, než sa klinicky považuje za primerané.

Prakticky to znamená, že **skríning a jasne definovaný cieľ liečby** musia predchádzať predpisu.

Odporúčania pre klinickú prax

Na základe uvedeného možno sformulovať praktický rámec:

1. **Pred predpisom GLP-1 vykonajte cielený diagnostický rozhovor** so zameraním na poruchy príjmu potravy, stratu kontroly pri jedení a telesno-estetické ciele.
2. **Pri podozrení na poruchu použite skríning** (napríklad BEDS-7) a zvážte konzultáciu s odborníkmi na duševné zdravie alebo poruchy príjmu potravy.
3. **Cieľ liečby stanovte ako metabolické zdravie, nie estetické „číslo“.** Ak pacient žiada výraznú zmenu vzhľadu bez medicínskeho dôvodu, je rozumné presunúť diskusiu na výživu, svalovú hmotu a prevenciu.
4. **Pri riziku malnutrície a straty svalstva** riešte príjem bielkovín, nutričnú kvalitu a frekvenciu kontrol. V niektorých prípadoch pomáha aj potravinový denník.
5. **Buďte opatrní pri telemedicínskom „skratkovom“ predpise.** Časť odborníkov volá po tom, aby sa aspoň na začiatku a pri kontrolách robilo posúdenie osobne.

Záver

Vyššia dostupnosť GLP-1 priniesla nielen lepší prístup k liečbe obezity, ale aj priestor pre nevhodné požiadavky. Kľúčom k zníženiu rizika je systematický skríning porúch príjmu potravy, jasné stanovenie cieľa liečby, edukácia o nutričných dôsledkoch a v rizikových situáciách včasné zapojenie psychologickej podpory.

Ak zvažujete GLP-1 u pacienta s hraničnou indikáciou, treba pamätať, že „túžba schudnúť“ nie vždy znamená medicínsku potrebu. Môže ísť o psychiatricky podmienený vzorec správania, ktorý si vyžaduje iný liečebný plán.

Zdroj: *Medscape Medical News, Are GLP-1s Increasing Eating Disorder Risk? (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-poruchy-prijmu-potravy-nevhodne-pouzivanie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.